

1. Résumé

L'objectif de ce cadre est d'atténuer l'ampleur et l'impact de flambées de choléra à grande échelle en République démocratique du Congo (RDC). Le cadre a été approuvé pour la première fois par le coordinateur des secours d'urgence (ERC) en décembre 2022 pour une période de deux ans, et a été prolongé en 2025. Le cadre a été activé deux fois en 2023, trois fois en 2025 et une fois en 2026, générant des enseignements qui ont alimenté la révision du présent cadre.

Le cadre a été élaboré conjointement par le Programme national pour l'élimination du choléra et la lutte contre les autres maladies diarrhéiques (PNECHOL-MD), l'UNICEF, l'OMS et OCHA.

Le cadre envisage deux **scénarios** distincts, chacun d'entre eux pouvant déclencher le cadre indépendamment :

- Scénario 1 : Risque accru d'une grande épidémie de choléra dans les provinces où la maladie est persistante ou la transmission continue de la maladie, c'est-à-dire les provinces de Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika, Haut Lomami et Haut Katanga (ci-après « provinces endémiques »).
- Scénario 2 : Risque accru d'une grande épidémie de choléra dans le reste du pays (ci-après « provinces non endémiques »).

Pour les deux scénarios, le niveau de risque est mesuré par un suivi continu du nombre de cas suspects de choléra. Si l'indicateur dépasse un seuil prédéterminé sur une période de trois semaines dans une zone de santé donnée, le cadre sera activé.

La mise en œuvre de l'action anticipatoire est guidée par un plan d'action convenu au préalable, qui sera mis en œuvre par deux agences - l'OMS et l'UNICEF. Ces agences mettront en œuvre des activités dans les secteurs de la santé et de l'eau, assainissement et hygiène en partenariat avec des ONG et en étroite coordination avec les autorités nationales et locales. Le plan d'action préétabli permettra :

- D'améliorer la détection précoce et réduire la transmission des cas de choléra en déployant des équipes d'intervention rapide de type CATI/Quadrillage, dans les foyers présentant des cas suspects, en fournissant des kits EAH, en diffusant des messages d'hygiène et en désinfectant ces foyers et les foyers environnants, et en renforçant les capacités de surveillance.
- De réduire le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de personnes dont le décès est dû à la maladie tout en étant admis dans une structure de prise en charge médicale en renforçant les capacités du secteur de la santé, notamment par la fourniture de kits sanitaires et la formation des personnels de santé.

Le financement de ce cadre est principalement assuré par le CERF, auquel l'ERC consacre en amont jusqu'à 4 millions de dollars US qui restera en vigueur pour une période de 2 ans à compter de l'approbation de l'ERC. L'enveloppe CERF pour chaque activation est limitée à 1 million de dollars US pour l'ensemble des partenaires impliqués dans la mise en œuvre des interventions liées au scénario activé. Cela signifie un total de maximum quatre activations. De plus, les partenaires fourniront un cofinancement afin de renforcer davantage l'impact du

cadre. Ce cadre fait partie du cadre mondial du CERF relatif au choléra, élaboré en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF, et visant à permettre des réponses rapides et standardisées aux flambées de choléra.

L'apprentissage

Alors que les activations précédentes ont démontré l'efficacité de l'approche, une composante d'apprentissage complète accompagnera le cadre afin de permettre la production de preuves supplémentaires.

Le cadre a été activé à six reprises par le passé, ce qui permet d'intégrer les enseignements tirés dans le cadre actuel. À titre d'exemple :

- Déclencheur : suppression des décès et de l'incidence en tant qu'indicateurs de risque ; ajustement du seuil de déclenchement (le seuil dans les provinces endémiques est passé de 99 à 174 cas, et dans les provinces non endémiques de 65 à 63 cas afin de tenir compte de la nature dynamique du choléra) ; ajustement annuel du seuil ; inclusion de la base de données SIMR (IDSR).
- Protocole d'activation amélioré.
- Plus grande flexibilité géographique dans la mise en œuvre.
- Renforcement de la coordination au niveau local.
- Plan d'action actualisé (par exemple, un accent renforcé sur la communication des risques et l'engagement communautaire ; clarification de la répartition des tâches dans le domaine de la gestion des cas ; prolongation du calendrier de mise en œuvre de 3 à 4 mois).
- Augmentation de l'enveloppe de financement du CERF de 750 000 par activation (pour un total maximum de 3 millions de dollars) à 1 000 000 par activation (pour un total maximum de 4 millions) conformément à la modification du déclencheur et dans le but d'assurer un impact maximal.

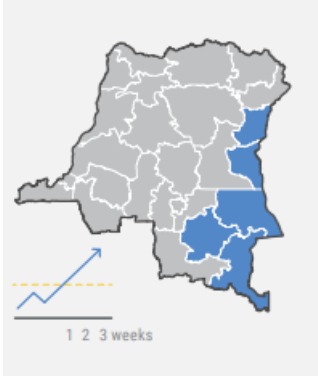
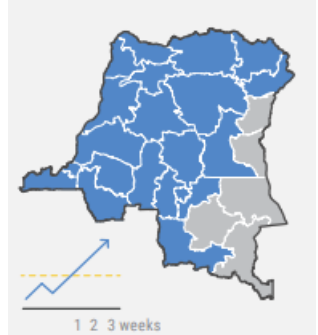
Contents

1.	Résumé.....	1
2.	Prévision et déclencheur.....	4
	Scénarios d'activation du cadre	4
	Surveillance épidémiologique	4
	Déclencheur et seuils.....	5
	Protocole d'activation : rôles et responsabilités dans le suivi du déclencheur	6
3.	Plan d'action anticipatoire	8
	Activités prioritaires	8
	Stratégie pour assurer une réponse rapide et efficace.....	8
	Flexibilité géographique	9
	Coordination et mise en œuvre	9
	Préparation	9
4.	Financements pré-convenus.....	12
5.	Apprentissage.....	13
	Suivi et évaluation	13
	Enseignements des activations précédentes	13
6.	Contexte et bénéfices de ce cadre	14
	L'action anticipatoire et les épidémies de choléra : contexte mondial.....	14
	Mettre fin au choléra	14
	Anticiper le choléra en RDC	14
	Bénéfices potentiel futur de ce cadre	15
7.	Annexe.....	16
	Objectifs de l'action anticipatoire.....	16
	Principes de base.....	16

2.Prévision et déclencheur

Scénarios d'activation du cadre

Pour faire face aux différentes situations qui représentent une augmentation du risque de flambée, deux différents scénarios ont été définis pour ce cadre en collaboration avec les partenaires humanitaires et nos collaborateurs scientifiques. Pour la définition des scénarios nous avons fait une distinction entre les provinces endémiques (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika, Haut-Lomami et Haut-Katanga) et les provinces non-endémiques (le reste du pays). Cette distinction a été faite sur la base de l'analyse des [zones à haut risque \(hotspots\)](#) faite par plusieurs acteurs. Cette distinction des différents scénarios permet de mieux adapter le déclencheur aux différents contextes.

	Seuil de déclenchement : Augmentation du risque de choléra sur la base d'indicateurs épidémiologiques
Provinces endémiques	
Provinces non- endémiques	

Représentation des deux scénarios de déclenchement du cadre

Surveillance épidémiologique

Les autorités nationales, et précisément le PNECHOL, ont la charge de la collection, validation et le partage des données épidémiologiques en RDC. Une collaboration entre l'équipe OCHA et le PNECHOL nous permet d'avoir accès direct à l'information de deux bases des données qui sont utilisées pour faire le suivi du déclencheur :

- **Niveau national** : Une base de données agrégées par zone de santé et semaine épidémiologique qui est mise à jour de manière hebdomadaire par l'équipe du PNECHOL. Les données dans cette base sont normalement disponibles seulement jusqu'à deux semaines avant la semaine courante à cause du travail d'agrégation et validation fait par le PNECHOL.

En outre, l'Organisation mondiale de la Santé partage des données de surveillance du choléra par le biais de du système de **surveillance intégrée des maladies et riposte (SIMR)** du ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale qui complète les données partagées par le PNECHOL.

Aucune information personnelle ou sensible est partagée par le PNECHOL ou d'autres autorités dans le cadre de ce projet et seulement les données agrégées par zone de santé et par semaine sont utilisées.

Déclencheur et seuils

Le déclencheur a été défini à travers un processus participatif avec les différents partenaires (PNECHOL-MD, UNICEF, OMS, Centre for Humanitarian Data) avec expérience soit dans la gestion de la réponse au choléra en RDC soit au niveau scientifique et épidémiologique. Le seuil de déclenchement a été calibré de manière à ce que l'allocation complète de 4 millions de dollars soit décaissée, en moyenne, une fois tous les deux ans, soit un décaissement annuel moyen de 2 millions de dollars.

Déclenchement sur la base d'indicateurs épidémiologique

Malgré les nombreux modèles épidémiologiques existants, qui tentent de prédire le tout début d'une flambée de cholera, ces modèles ne sont pas assez fiables pour être utilisées comme déclencheur pour ce cadre. Le déclencheur pour les deux scénarios est donc basé sur les données épidémiologiques hebdomadaires et locales (aux niveaux des zones de santé). L'objectif est d'anticiper une flambée majeure. Sur la base des données historiques, la probabilité de déclenchement est estimée à une occurrence tous les six mois en moyenne, en fonction des différents scénarios.

Un système d'alerte basé sur le nombre de cas suspects, considérant des données historiques et de l'augmentation par rapport à la semaine précédente, a été défini pour chaque scénario, sur la base.

Le déclencheur est atteint si :

- Une zone de santé reste à **en alerte cholera pendant 3 semaines consécutives ; ET**
- Au moins un cas suspect dans cette zone de santé est confirmé par les laboratoires dans les trente jours précédents

Pour 2026, le niveau d'alerte est défini comme suit :

- **174 cas/semaine dans une même zone de santé au sein des provinces endémiques, 63 cas dans les provinces non endémiques**
- **OU une augmentation de 4 fois des cas suspects par rapport à la semaine précédente dans une même zone de santé**
- **OU une combinaison de ces deux conditions.**

Paramètres

Le seuil est mis à jour chaque année en janvier sur la base des données des cinq dernières années afin de maintenir la période de retour envisagée. Les nouveaux seuils seront calculés par le Centre for Humanitarian Data et communiqués par courrier électronique à l'ensemble des parties prenantes, notamment l'OMS, l'UNICEF, le bureau national d'OCHA, le siège d'OCHA (CERF, CIS, CRD), le bureau régional d'OCHA (ROWCA), le PNECHOL-MD et le/la CR/CH. Le document-cadre sera également mis à jour pour tenir compte de ces nouveaux seuils. Cet ajustement ne nécessite pas d'approbation supplémentaire.

Si le cadre est activé une fois et les fonds sont déboursés, le CERF ne pourra pas décaisser des fonds à nouveau pour ce scénario dans la même province ou une province limitrophe **pendant une période de six mois**. Cependant, si la situation le justifie, le/la CR/CH pourra soumettre une demande d'allocation au titre de la fenêtre Réponse Rapide classique.

Par exemple : si des fonds sont déboursés pour le Tanganyika dans le cadre du scénario 1 en janvier 2026, jusqu'en fin juin ni le Tanganyika, ni le Haut-Lomami, le Haut-Katanga et le Sud-Kivu ne pourront recevoir des

fonds dans le cadre, même si le seuil de déclenchement est atteint. Cependant, les partenaires pourront solliciter une révision pour inclure de nouvelles provinces adjacentes dans les zones ciblées par l'allocation en cours comme indiqué dans la partie "flexibilité stratégique".

Les déclencheurs pour les différents scénarios sont donc définis comme suit :

	Scénario 1 et 2
Indicateur sélectionné	Cas suspects
Seuils	Au moins une zone de santé en niveau d'alerte pendant 3 semaines consécutives
D'indicateurs épidémiologiques	Au moins un cas confirmé par les laboratoires dans le mois précédent
Limitation des déclenchements consécutifs	Pas d'activation du même cadre dans la même province ou dans une province limitrophe dans les 6 mois précédents

Protocole d'activation : rôles et responsabilités dans le suivi du déclencheur

L'équipe OCHA du *Centre for Humanitarian Data* (CHD) est responsable de faire le suivi des indicateurs épidémiologiques et d'envoyer l'alerte aux partenaires une fois que le seuil pour les scénarios 1 et 2 soit atteint. Différents acteurs sont impliqués dans le protocole d'activation :

- **Coordinateur humanitaire** : informera l'Equipe Humanitaire Pays si les seuils de déclenchement ont été atteints
- **PNECHOL-MD, OMS** : responsable pour le partage des données et la mise à jour des bases des données.
- **OCHA RDC** : responsable pour la coordination au sein de la task force nationale (PNECHOL-MD, UNICEF, OMS, OCHA)
- **OCHA Centre for Humanitarian Data (CHD)** : responsable pour la mise à jour de la plateforme, du suivi et de la notification de tous les partenaires en cas d'activation.
- **CERF** : responsable pour le décaissement des fonds.
- **OMS, UNICEF** et leurs partenaires : responsable pour la capacité opérationnelle, les préparatifs, la soumission des projets et la mise en œuvre des actions anticipatoires en temps et en heure.

Le tableau suivant décrit le processus d'activation lorsqu'un seuil de déclenchement a été atteint :

Acteur	Responsabilité
OCHA Centre for Humanitarian Data (CHD)	Notifier à l'OMS, à l'UNICEF, au bureau national d'OCHA, au siège d'OCHA (CERF, CIS, CRD), au bureau régional d'OCHA (ROWCA), au PNECHOL-MD et au CR/CH que le seuil de déclenchement a été atteint et dans quelle zone de santé.
OMS, UNICEF	Informar OCHA dans les 48 heures s'ils souhaitent collectivement renoncer à l'activation, en précisant la raison. En cas de désaccord entre les agences, la direction de l'Organisation mondiale de la Santé, de l'UNICEF, du PNECHOL et de l'OCHA prendra une décision dans un délai supplémentaire de 24 heures. Si aucun accord n'est trouvé, le cadre ne sera pas activé.
OCHA RDC	Informe l'OMS, l'UNICEF, le bureau national de l'OCHA, le siège de l'OCHA (CERF, CIS, CRD), le bureau régional de l'OCHA (ROWCA), le PNECHOL-MD et le CR/CH si les agences ont choisi de ne pas procéder à l'activation.

CERF	Si aucune objection n'est soulevée : Envoyer des lettres d'approbation des projets aux sièges des agences et déblocage des fonds.
OMS, UNICEF et leurs partenaires	Commencer immédiatement leur mise en œuvre.

3. Plan d'action anticipatoire

Activités prioritaires

Les actions anticipatoires dans ce cadre viseront à contenir les flambées de choléra en réduisant l'ampleur et de mitiger leurs propagations.

Ces activités s'accordent avec les objectifs spécifiques du Plan de réponse humanitaire de la RDC (2026), ainsi qu'avec les recommandations du Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra (GTFCC)¹.

Le tableau récapitulatif ci-dessous donne un aperçu des activités proposées par chaque agence. Plus de détails peuvent être trouvés dans les documents de projet CERF.

Les agences des Nations Unies impliquées dans la mise en œuvre des plans d'action soumettront des mises à jour régulière en utilisant un modèle prédéterminé. Le suivi devrait porter sur les objectifs initiaux, le nombre d'intrants livrés, le nombre de personnes atteintes et le temps nécessaire pour livrer les intrants par rapport au premier cas suspect par unité géographique prédéfinie.

Stratégie pour assurer une réponse rapide et efficace

L'OMS et l'UNICEF ont l'expérience de la gestion des épidémies de choléra dans les zones endémiques et non-endémiques de la République démocratique du Congo. Les deux agences s'engagent à se coordonner et à se compléter. Par exemple, les agences coordonnent leurs activités liées à la surveillance et à la détection rapide, et se soutiennent mutuellement dans les domaines de la gestion des cas et de la réponse rapide.

OMS

L'approche de l'OMS vise à réduire la transmission du choléra à travers :

- **Le renforcement de la prise en charge des cas de choléra dans les centres/unités de traitement du choléra** : L'objectif est de réduire la létalité ;
- **L'appui aux activités communautaires de « quadrillage »** : L'objectif est de désinfecter les ménages cas et environnants, en assurant la chloration de l'eau et la sensibilisation de la communauté en vue de couper la chaîne de propagation et l'appropriation/pérennisation ;
- **Le renforcement des capacités de surveillance épidémiologique et biologique** : L'objectif est la détection précoce, l'investigation de cas suspects de choléra et leur référencement ;
- **Le renforcement des équipes d'intervention rapide et relais communautaires** : L'objectif est d'assurer la remontée précoce des alertes, le prélèvement des échantillons et d'assurer les enterrements dignes et sécurisés.

UNICEF

Depuis 2020, l'UNICEF a mis en œuvre son approche d'interventions ciblées par zone de cas (CATI). Cette approche vise à réduire la transmission du choléra au niveau des ménages et des communautés à travers :

- **Le renforcement de la coordination et la détection rapide des cas suspects et confirmés** : L'objectif est de faciliter une réponse ciblée, autour de chaque cas suspect ou confirmés, mais également orienter les actions EAH/santé de second niveau afin de réduire le risque de reprise épidémique ;
- **La mise en œuvre de la réponse rapide ciblée autour des cas suspects de choléra dans les communautés** : L'objectif est de contribuer à interrompre la transmission par la mise en œuvre de cordons sanitaires dans et autour du foyer affecté (cible : 80% des cas suspects et confirmés répondus en moins de 48h) ;
- **L'engagement communautaire et intensification de la promotion de l'hygiène** : L'objectif est de réduire la transmission de la maladie en amont des périodes considérées à risque ou lors d'un retour à

¹ GTFCC, *Réponse à l'épidémie de choléra : Manuel de terrain*, 2019.

une situation de contrôle. En effet, la réduction de la charge microbienne circulant dans la population permet de réduire l'effet catalyseurs des précipitations et autres facteurs de risque saisonniers

- **Le renforcement des centres/unités de traitement du choléra** : L'objectif est de réduire la létalité.

Flexibilité géographique

La période d'incubation du choléra étant courte (2 heures à 5 jours), le nombre de cas peut augmenter rapidement. La détection et la confirmation précoce des cas nécessitent donc une réponse agile. Par conséquent, une fois le seuil de déclenchement pour de l'un des scénarios atteint, l'UNICEF et l'OMS auront la flexibilité d'utiliser le financement du CERF pour intervenir dans toutes les zones de santé préoccupantes liées à la zone de santé où le seuil de déclenchement est atteint, et pas seulement dans cette dernière. Les partenaires s'engagent à coordonner leurs activités afin de garantir une réponse complémentaire. Les zones de santé où le seuil est atteint font l'objet d'un ciblage conjoint. Le ciblage est fondé sur une analyse commune menée par OCHA, le PNECHOL, l'OMS et l'UNICEF (la « task force »). Une extension à d'autres zones de santé, situées dans la même province ou dans une province adjacente, est possible après accord de la task force. Des interventions unilatérales peuvent également être envisagées, sous réserve de l'accord de la task force.

Coordination et mise en œuvre

Des réunions hebdomadaires sont organisées au niveau local entre les partenaires de mise en œuvre. Au niveau des agences, les réunions bimensuelles avec OCHA et le CERF sont maintenues, notamment les réunions du jeudi. Afin d'atteindre les objectifs de ce cadre, les partenaires visent à lancer leur réponse dès que les seuils de déclenchement sont atteints et à mettre en œuvre l'ensemble des activités dans un délai de quatre mois à compter de l'activation.

Préparation

OMS

En collaboration directe avec les Divisions provinciales et le système de collecte actif de surveillance de l'OMS :

- Activités de renforcement de capacité de réponse aux épidémies en faveur des équipes des zones de santé ;
- Prépositionnement d'intrants de prise en charge dans les zones de santé à risques ;
- Prépositionnement d'épidémiologistes dans 400 des 515 zones de santé de la RDC avec possibilité de déploiement en cas d'activation.

UNICEF

- Partenariats avec des ONG nationales dans les zones endémiques, incluant des équipes mobiles pouvant se déplacer vers une zone épidémique pour réponse et formation ;
 - Liste de partenaires éligibles identifiés à travers un appel à manifestation d'intérêt ;
 - Programme de contingence, permettant une activation rapide d'un nouveau partenariat dans les zones non couvertes par l'UNICEF ;
- Prépositionnement d'intrants chez les partenaires d'implémentation et dans les entrepôts UNICEF dans des zones stratégiques

Tableau de résumé

Agence	Partenaires	Intervention	Activités proposées
UNICEF	Croix-Rouge Nord-Kivu, Croix-Rouge Sud-Kivu, Croix-Rouge Tanganyika, Ami Labo, PPSSP, VIPATU	Interventions ciblées par zone de cas (CATI) et EAH	• Déploiement d'équipes de réponse rapide (RRT) • Détection précoce des cas • Distribution de kits choléra (EAH) • Désinfection des ménages cas et 20 ménages contacts • Promotion de l'hygiène • Chloration aux points de puisage et sensibilisation Désinfection et réhabilitation de points d'eau • Installation de blocs de latrines publiques • Distribution de kits EAH choléra dans les écoles, accompagnée d'activités de promotion de l'hygiène • Activités de changement de comportement •
UNICEF	Croix-Rouge Nord-Kivu, Croix-Rouge Sud-Kivu, Croix-Rouge Tanganyika, Ami Labo, PPSSP, VIPATU	Assurer la prise en charge médicale des patients infectés	• Réhabilitation rapide de Centres/Unités de traitement du choléra/ Points de Réhydratation Orale (PRO) • Protection Contre l'Infection (PCI) dans les établissements des soins/CTC, UTC (installation de points d'eau, latrines, zone à déchet ...)
OMS	ADRA, MDA (Médecins d'Afrique), Alima	Quadrillage	• Désinfection, traitement de l'eau et sensibilisation au choléra dans les foyers touchés et les foyers environnants •
OMS	ADRA, MDA (Médecins d'Afrique), Alima	Renforcer la surveillance et la détection précoce	• Alerte, détection précoce des cas et investigations • Soutien aux enquêtes/investigations sur les cas suspects ; distribution d'affiche de définition des cas • Distribution de tests de diagnostic rapide (TDR) et de supports de transport Cary Blair ; soutien au transport des échantillons prélevés vers les laboratoires • Fourniture d'outils de surveillance aux établissements de santé
OMS	ADRA, MDA (Médecins d'Afrique), Alima	Assurer la prise en charge médicale des patients infectés	• Distribution de kits choléra de prise en charge au niveau central, périphérique et communautaire

- Formation des relais communautaires et autres personnels de santé sur la gestion du choléra
- Formation des hygiénistes sur les techniques de désinfections
- Transport des hygiénistes et autres personnels d'exécution
- PCI dans les établissements des soins/CTC, UTC (inclus la dotation de kits PCI/IPC)
- Enterrement digne et sécurisé en dotant le sac mortuaire
- Traitement médical en dernier recours
- Mise en place des PRO

4. Financements pré-convenus

Pour le cadre d'action anticipatoire en RDC, l'ERC a accepté d'allouer jusqu'à 4 millions de dollars US si les seuils de déclenchement sont atteints. Chaque allocation est plafonnée à 1 million de dollars US, permettant un maximum de 4 activations pendant la période de validité de 2 ans.

Les fonds du CERF seront décaissés une fois que le déclencheur de l'action d'anticipation sera activé (voir 3. *Prévision et déclencheur : protocole d'activation*).

Le CERF décaissera les fonds une fois que trois conditions seront remplies :

- **Approbation par le/la Coordonnateur/rice Résident/e / Humanitaire** concerné(e) du cadre d'action anticipatoire spécifique à la RDC et du dossier de candidature CERF comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projet spécifiques à l'agence et des budgets spécifiques à l'agence ; et
- **Approbation par le ERC du cadre d'action anticipatoire spécifique contre le choléra en RDC et du dossier de candidature CERF** comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projet spécifiques à l'agence et des budgets spécifiques à l'agence (cela devrait être une approbation préalablement convenue)
- **Activation du déclencheur** préalablement convenu, dans un délai maximum de deux ans à compter de l'approbation du cadre par l'ERC ; et
- **Les partenaires n'ont pas formulé d'objection** à l'activation conformément au protocole d'activation.

En plus du CERF, les partenaires fournissent des financements supplémentaires afin de permettre et d'accroître l'ampleur de l'assistance.

Agence	Financement CERF (en USD)	Cofinancement de préparation (en USD)	Cofinancement de mise en œuvre (en USD)	Total (en USD)
UNICEF	2 000 000	200 000		2 200 000
WHO	2 000 000	160 000	120 000	2 280 000
TOTAL	4 000 000	360 000	120 000	4 480 000

Ce cadre fait partie de la stratégie mondiale du CERF relatif au choléra, élaboré en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF, et visant à permettre des réponses rapides et standardisées aux flambées de choléra.

Remarque : L'existence d'un cadre d'action anticipatoire financé par le CERF n'exclut pas la possibilité pour le/la RC/HC et le HCT de solliciter un financement additionnel du CERF au titre de la réponse rapide pour faire face au même choc ou à d'autres chocs éventuels. Elle ne constitue toutefois pas une garantie que ce financement sera accordé.

5. Apprentissage

Suivi et évaluation

Chaque agence utilisera ses systèmes de suivi et d'évaluation existants pour collecter et suivre les données relatives aux progrès de la mise en œuvre et aux résultats obtenus. Tous les rapports et conclusions seront partagés. En outre, des discussions sont en cours, y compris avec des partenaires externes, concernant un agenda d'apprentissage collectif afin de mieux comprendre les bénéfices de l'approche, avec un accent particulier sur l'impact, la rapidité et le rapport coût-efficacité par rapport à une réponse standard.

Une réunion de revue après action (after action review) sera systématiquement organisée avec les parties prenantes à la fin de chaque activation afin d'identifier les leçons apprises et les bonnes pratiques.

Enseignements des activations précédentes

Le cadre a été activé à six reprises par le passé, ce qui permet d'intégrer les enseignements tirés dans le cadre actuel. À titre d'exemple :

- Déclencheur : suppression des décès et de l'incidence en tant qu'indicateurs de risque ; ajustement du seuil de déclenchement (le seuil dans les provinces endémiques est passé de 99 à 174 cas, et dans les provinces non endémiques de 65 à 63 cas afin de tenir compte de la nature dynamique du choléra) ; ajustement annuel du seuil ; inclusion de la base de données SIMR (IDSR).
- Protocole d'activation amélioré.
- Plus grande flexibilité géographique dans la mise en œuvre.
- Renforcement de la coordination au niveau local.
- Plan d'action actualisé (par exemple, un accent renforcé sur la communication des risques et l'engagement communautaire ; clarification de la répartition des tâches dans le domaine de la gestion des cas ; prolongation du calendrier de mise en œuvre de 3 à 4 mois).
- Augmentation de l'enveloppe de financement du CERF de 750 000 par activation (pour un total maximum de 3 millions de dollars) à 1 000 000 par activation (pour un total maximum de 4 millions) conformément à la modification du déclencheur et dans le but d'assurer un impact maximal.

6. Contexte et bénéfices de ce cadre

L'action anticipatoire et les épidémies de choléra : contexte mondial

Depuis plus d'un siècle, le traitement moderne des eaux usées et de l'eau a pratiquement éliminé le choléra dans les pays industrialisés. Pourtant, le choléra persiste. Son fardeau pèse le plus lourd sur les pays qui peuvent le moins se le permettre, dont beaucoup souffrent de crises humanitaires prolongées. Les conditions d'insalubrité, l'extrême pauvreté, les conflits et le changement climatique exacerbent son impact.

Bien que le choléra soit entièrement évitable, et que son traitement soit cliniquement simple et relativement peu coûteux, il peut se propager rapidement et tuer en quelques heures s'il n'est pas traité. On estime que, chaque année, il y a jusqu'à 4 millions de cas de choléra et 143 000 décès dans le monde.²

Mettre fin au choléra

Des solutions existent. Le Groupe de travail mondial pour la lutte contre le choléra (GTFCC), dont le secrétariat est situé à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a élaboré une [feuille de route à l'horizon](#) pour aider vingt pays à éliminer le choléra d'ici 2030 en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de flambées de choléra dans les milieux vulnérables et ainsi, réduire de 90% les décès dus au choléra. Il est fondamental que l'action et les investissements collectifs continuent de progresser vers cet objectif.

En attendant, il n'y a aucune raison d'attendre l'apparition de grandes épidémies avant de répondre. Il est possible, tout en étant plus digne et plus rentable, d'utiliser les données pour contenir une épidémie avant qu'elle ne devienne une crise.

C'est pourquoi, depuis quelques années, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) travaille avec les communautés scientifiques et de santé publique mondiales, ainsi qu'avec les organisations humanitaires, sur la possibilité de prédire et d'anticiper le choléra. Ce cadre d'action anticipatoire pour la RDC est une matérialisation de cet effort.

Anticiper le choléra en RDC

La RDC reste l'une des crises humanitaires les plus complexes et les plus prolongées au monde, affectée par plusieurs impacts humanitaires, notamment : les mouvements de population, l'insécurité alimentaire aiguë, la malnutrition aiguë, les épidémies, les problèmes de protection et les conflits armés. Des épidémies surviennent souvent aussi dans des zones non endémiques du centre et de l'ouest du pays. L'environnement opérationnel est extrêmement complexe et volatile. Le Forum des ONG internationales de la RDC, par exemple, note que "répondre aux besoins humanitaires en RDC est exceptionnellement difficile car l'accès est une lutte constante, en raison des obstacles administratifs, des défis logistiques, de l'isolement de certaines zones du pays et de la détérioration de la situation sécuritaire." Par conséquent, tout temps gagné dans le contrôle et la prévention de la propagation du choléra permet de sauver des vies.

Au milieu de ces défis et de cette fragilité structurelle, l'action anticipatoire contre le choléra en RDC nécessite d'optimiser les systèmes, les capacités et l'expérience existants. La conception de ce cadre et sa mise en œuvre ne sont possibles que grâce à la forte collaboration entre les autorités sanitaires, les agences des Nations Unies, la Croix-Rouge et les communautés locales. Les approches opérationnelles – telles que l'approche communautaire ciblée de lutte contre le choléra par la technique du quadrillage (ACTQ) expérimentée en RDC et la réponse rapide ciblée autour des cas (CATI) qui ont fait leurs preuves dans des pays comme Haïti – s'avèrent efficaces et complémentaires en RDC. Car l'approche Quadrillage est communautaire de masse et répond aux grandes flambées épidémiques et CATI est ciblée et répond bien dans des flambées de taille réduite ou des cas sporadiques, et en début d'épidémie et à la queue d'épidémie. Cependant, avec des ressources limitées et des épidémies dépassant souvent la capacité des agences et des réseaux de soins de santé

² <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera>

communautaires, les flambées de choléra peuvent rapidement devenir de grands incendies. Ce cadre vise à déclencher le déblocage de fonds beaucoup plus tôt que ce n'est le cas typiquement, afin d'intervenir rapidement là où des cas sont détectés et, par conséquent, d'empêcher qu'un petit foyer de cas ne se transforme en une grande épidémie incontrôlée. C'est dans ce sens que l'action anticipatoire a été définie pour le choléra.

Depuis sa mise en place en 2022, ce cadre d'action anticipatoire contre le choléra, le premier de ce type pour l'OCHA, a été activé à six reprises : deux fois en 2023, trois fois en 2025 et une fois en 2026 — ces dernières activations reflétant l'une des pires épidémies qu'ait connues le pays depuis 25 ans³. Plusieurs enseignements tirés des activations précédentes ont été intégrés dans ce cadre révisé, notamment des améliorations du mécanisme de déclenchement, un renforcement de la coordination, ainsi qu'une augmentation de l'enveloppe de financement (voir la section « 6. Apprentissage » pour plus de détails).

Bénéfices potentiel futur de ce cadre

A l'avenir, OCHA et ses partenaires continueront à travailler ensemble pour encourager l'apprentissage collectif à partir des preuves générées par ce cadre en RDC. Il est possible que les leçons apprises à travers ce cadre serviront comme guide pour d'autres pays, et pourront aussi informer la lutte contre d'autres épidémies (par exemple, Ebola).

De même, nous continuerons à suivre les progrès scientifiques et le développement d'outils et d'approches de prévision du choléra qui intègrent des informations climatiques et météorologiques (c'est-à-dire des déclencheurs environnementaux), des données sur la mobilité humaine et des données socio-économiques, des ensembles de données sur l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement, etc.

³ <https://www.unicef.org/press-releases/democratic-republic-congo-cholera-outbreak-declared-countrys-worst-25-years>

7. Annexe

Objectifs de l'action anticipatoire

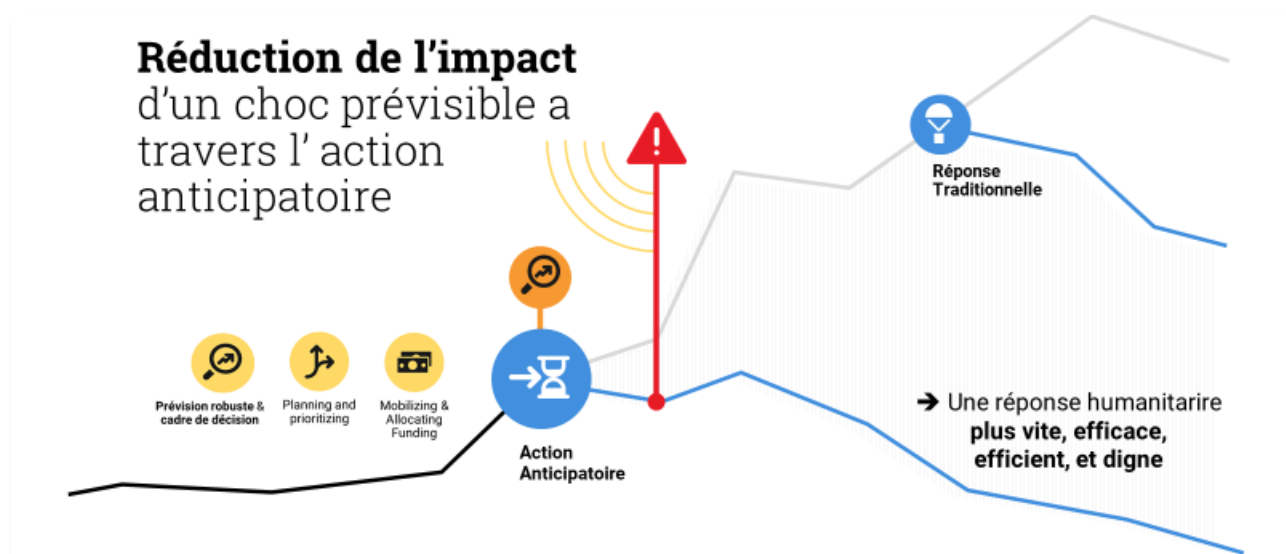
Il existe une convergence de point de vue que l'aide humanitaire internationale doit passer d'une approche largement réactive à une approche anticipative : planifier la survenue d'une prochaine catastrophe, mettre en place un plan d'action et les financements avant la catastrophe, décaisser les fonds pour agir rapidement pour réduire son impact et donc limiter les besoins humanitaires. Une approche anticipatoire conduit à une réponse plus efficace, efficiente et digne. Il protège également les progrès durement acquis de développement.

Aujourd'hui, il est possible de prédire avec un haut degré de confiance la survenue et les conséquences humanitaires de l'impact de certains chocs climatiques et des épidémies. De nombreuses évidences montrent qu'agir avant l'apparition d'un danger prévisible, ou avant que son impact n'atteigne son pic, est beaucoup plus efficace que la réponse humanitaire traditionnelle. OCHA s'engage à faciliter la mise en place des actions anticipatoires collectives contenues dans ce cadre.

Chaque cadre comprend 3 éléments de base, qui sont tous étayés par un plan clair d'apprentissage, de suivi et d'évaluation :

- Une prévision robuste intégrée dans un processus décisionnel clair (**le modèle**).
- Plan d'action préalablement convenu qui peut modifier fondamentalement la trajectoire de la crise (**la livraison**).
- Financement pré-discuté et convenu (**l'argent**).

L'action anticipatoire reste un espace innovant. Ainsi, en plus des 3 éléments de base, OCHA investit également dans la documentation des preuves et l'apprentissage de chaque cadre.



Principes de base

Comme pour tous les cadres mis en œuvre et facilités par OCHA, ce cadre d'actions anticipatoires a suivi les préalables ci-dessous :

- **Consensus, simple, rapide et prévisible** : Le cadre est la résultante d'un travail consensuel d'un groupe de partenaires désireux et capables de mener des actions anticipatoires et qui disposent déjà d'une expertise avérée en matière d'actions anticipatoires.

- **Promouvoir la redevabilité vis-à-vis des populations affectées** : les partenaires engagés dans la mise en œuvre du cadre d'action anticipatoire sont responsables de l'intégration des démarches de redevabilité vis-à-vis des populations affectées dans leurs activités. Cela comprend tout effort pour solliciter, entendre et agir en fonction des voix et des priorités des personnes affectées (y compris les femmes, les hommes, les filles et les garçons les plus marginalisés et à risque) de manière coordonnée, avant, pendant et après l'action anticipatoire. Cela signifie également s'assurer que les commentaires de la communauté conduisent à des actions correctives dans les futures actions anticipatoires.
- **Assurer la centralité de la protection** : conformément à la centralité de la politique de protection de l'IASC et au principe de «ne laisser personne de côté » (Programme 2030), tous les partenaires mettant en œuvre des activités anticipatoires ont la responsabilité de s'assurer que leur réponse n'aggrave pas l'exposition des communautés aux risques de violence, d'insécurité, d'extorsion et d'exploitation. Les activités anticipatoires doivent également garantir qu'elles profitent à toutes les communautés (communautés locales, communautés déplacées, rapatriés et réfugiés) en fonction de leurs besoins, en accordant une attention particulière aux obstacles liés au sexe, à l'âge, au handicap ou à l'appartenance sociale.
- **S'engager dans des partenariats** : La collaboration entre les acteurs humanitaires et également avec les autorités sanitaires national, provinciales et locales est essentielle pour garantir que tous les secteurs sont engagés et que l'aide est mobilisée conformément au cadre de l'action anticipatoire.
- **Capter l'apprentissage et viser l'intégration dans les protocoles nationales et cycle de planification humanitaire** des activités de suivi, d'évaluation et d'apprentissage seront documentées tout au long du cadre. Les résultats seront présentés à l'EHP afin de voir comment les activités d'action anticipatoire pourraient être intégrées dans le cycle de planification humanitaire.

Approuvé par l'Equipe Humanitaire Pays le 11 juin 2026

Et,

Damien Mama

Coordonnateur Humanitaire ad interim pour la République démocratique du Congo

Le 12 juin 2026